

CHAPITRE

01

La santé publique et la promotion de la santé en nutrition

Santé publique | Promotion de la santé | Politiques nutritionnelles

DANS CE VOLUME

- ✓ Définitions clés
- ✓ Formules et méthodes
- ✓ Fiches-outils
- ✓ Révision express

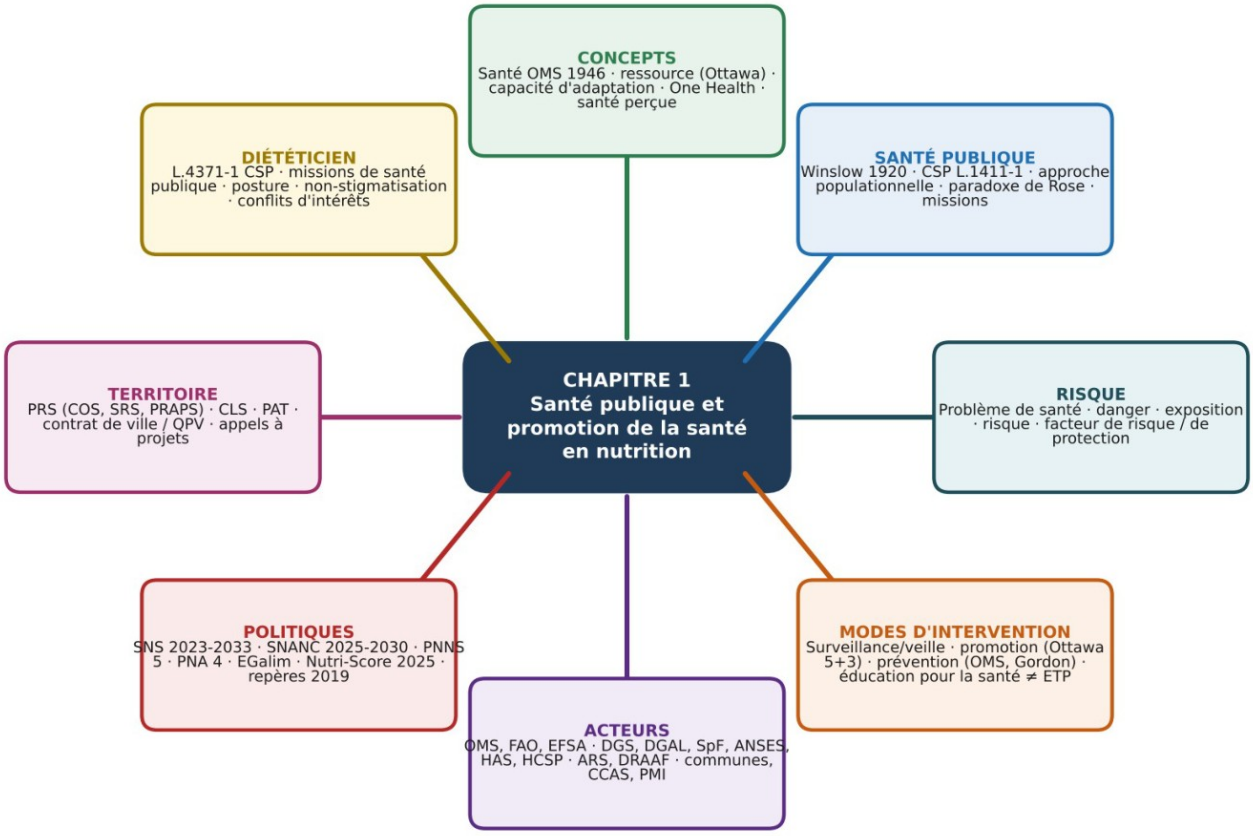
Sommaire

Fiche de révision du chapitre 1 3
1. Les définitions à savoir par cœur 3
2. Les classifications à ne pas confondre 4
3. La Charte d'Ottawa : 5 + 3 4
4. Les dates et textes à jour (octobre 2026) 4
5. Chiffres-clés 5
6. Les pièges classiques 5
7. Méthode express pour l'oral E5 : qualifier son action en 4 phrases 5
8. Auto-test (réponses en bas de page) 5
9. Flashcards à découper 6

Fiches-outils du chapitre 1 6
O1.1 – Qualifier mon action 7
O1.2 – Portrait express de mon territoire 7
O1.3 – Carte des acteurs de mon territoire 8
O1.4 – Inscrire mon projet dans les politiques en vigueur 8
O1.5 – Analyser un projet avec la Charte d'Ottawa 9
O1.6 – Les déterminants de l'alimentation de mon public 9
O1.7 – Tableau de veille des politiques nutritionnelles 10
O1.8 – Check-list éthique et non-stigmatisation d'un message ou d'un support 10

Fiche de révision du chapitre 1

Santé publique, promotion de la santé et politiques nutritionnelles



Carte mentale du chapitre 1

1. Les définitions à savoir par cœur

Notion	Définition	Source, date
Santé	« État de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité »	OMS, Constitution, 1946
Santé (ressource)	« Ressource de la vie quotidienne, et non le but de la vie »	Charte d'Ottawa, 1986
One Health	Approche intégrée visant à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes	OHHLEP / Quadripartite, 2021-2022
Santé publique	Science et art de prévenir les maladies, prolonger la vie et promouvoir la santé par les efforts coordonnés de la communauté	Winslow, 1920
Promotion de la santé	Processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci	Charte d'Ottawa, 21/11/1986

Notion	Définition	Source, date
Prévention	Ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps	OMS, 1948
Éducation pour la santé	Permettre à chacun d'acquérir les compétences et les moyens de promouvoir sa santé et celle de la collectivité	PNES, 2001
Universalisme proportionné	Actions pour tous, d'intensité proportionnelle au désavantage social	Marmot, 2010
Danger / risque	Danger = capacité à nuire ; risque = probabilité de l'effet néfaste (danger × exposition)	–

2. Les classifications à ne pas confondre

Prévention OMS (moment)	Indicateur visé	Gordon (public)	Exemple
Primaire : avant la maladie	Incidence	Universelle : tous	Repères PNNS, atelier cuisine pour tous
Secondaire : début, dépistage	Prévalence	Sélective : groupe à risque	Ateliers en QPV ; dépistage de la dénutrition
Tertiaire : maladie installée	Complications, récidives	Indiquée : facteurs de risque présents	ETP diabète (BC1) ; programme enfants en surpoids
Quaternaire (Jamoulle)	Surmédicalisation	–	Éviter les régimes inutiles

Patients atteints de maladie Déterminants, milieux, Compétences des personnes Un problème de santé défini chronique, programme déclaré politiques, pouvoir d'agir bien portantes à l'ARS

3. La Charte d'Ottawa : 5 + 3

- **5 domaines** : politique publique saine – milieux favorables – action communautaire – aptitudes individuelles
- réorientation des services de santé (« **P**our **M**anger **C**orrectement, **A**gissons **R**apidement »).
- **3 stratégies** : plaider – conférer les moyens – servir de médiateur.

4. Les dates et textes à jour (octobre 2026)

Date	Texte
1946 / 1948	Constitution de l'OMS (signée / entrée en vigueur)
1986	Charte d'Ottawa
2001	PNNS 1
2004	Loi relative à la politique de santé publique (PNNS dans la loi, distributeurs interdits à l'école)
2009	Loi HPST (ARS, ETP)
2014	Loi d'avenir pour l'agriculture (PAT)
2016	Loi de modernisation de notre système de santé (Nutri-Score, 2017)
2018	Loi EGalim (50 % durables et de qualité dont 20 % bio)
2019	Repères alimentaires Santé publique France ; PNNS 4 (2019-2023)
2021	Loi Climat et résilience (art. 265 : SNANC)
14/03/2025	Nouvel algorithme du Nutri-Score (arrêté)

Date	Texte
Juin 2025	Avis du HCSP pour le PNNS 5 ; lancement de l'enquête Albane
11/02/2026	SNANC 2025-2030 publiée
08/04/2026	PNNS 5 et PNA 4 (2026-2030) lancés (One Health Summit, Lyon)

5. Chiffres-clés

- Obésité de l'adulte : **18,1 %** (OFÉO 2024) ; 22,4 % outre-mer ; 24,7 % en cas de difficultés économiques.
- Surpoids des 6-17 ans : **17 %** dont 4 % d'obésité (ESTEBAN 2015).
- Précarité alimentaire : **16 %** (Crédoc 2022).
- 5 fruits et légumes/jour : **30 %** des adultes, 20 % des enfants ; fibres < 25 g/j : 90 % des adultes (HCSP 2025).
- Espérance de vie 2025 : **85,9 ans** (F), **80,3 ans** (H) ; écart de ≈ 13 ans entre hommes aisés et modestes.
- PNNS 5 : **3 axes, 20 mesures**, − 30 % de surpoids et d'obésité chez les enfants et adolescents (− 20 % chez les plus défavorisés).
- EGalim (achats 2023) : ≈ 25,5 % durables et de qualité, 12,1 % bio.

6. Les pièges classiques

Attention

- Citer le **PNNS 4** comme en vigueur → c'est le **PNNS 5 (2026-2030)**.
- Dire que le **Nutri-Score est obligatoire** → il est **facultatif**.
- Classer le **dépistage** en prévention primaire → **secondaire**.
- Appeler « éducation pour la santé » un atelier destiné à des **patients** d'un programme d'ETP → c'est de l'**ETP** (BC1).
- Confondre **incidence** (nouveaux cas) et **prévalence** (cas existants).
- Comparer des chiffres issus de **méthodes différentes** (mesuré / déclaré).
- Oublier les **déterminants** et proposer uniquement de l'information.

7. Méthode express pour l'oral E5 : qualifier son action en 4 phrases

1. Mode d'intervention : « Mon projet est une action d'éducation pour la santé (alimentaire/nutritionnelle/sensorielle)… »

2. Prévention : « … au service de la prévention primaire, sélective, car le public… »

3. Promotion de la santé : « Il s'inscrit dans une démarche de promotion de la santé car… (participation, milieu favorable, partenariat). »

4. Politiques : « Il répond à l'axe … du PNNS 5 (2026-2030), à l'objectif … du PRS et à la fiche-action … du CLS. »

8. Auto-test (réponses en bas de page)

1. Qui a défini la santé publique en 1920 ?

2. Quels sont les 5 domaines d'action de la Charte d'Ottawa ?

3. Quel niveau de prévention fait baisser l'incidence ?

4. Quelle classification distingue universelle, sélective et indiquée ?

5. Quelle loi prévoit la SNANC ? Quand a-t-elle été publiée ?

6. Combien d'axes et d'actions compte le PNNS 5 ?

7. Quels sont les deux seuils EGalim en restauration collective ?

8. Quel organisme conduit les études INCA ? Et ESTEBAN ?

9. Que contient un PRS ?

10. Calculez le coût par portion d'une recette de 9,60 € pour 12 portions.

11. Une diététicienne anime un atelier pour des patients d'un programme ETP diabète : de quoi s'agit-il ?

12. Donnez la formule du taux d'atteinte d'un indicateur. *Réponses : 1. Winslow – 2. Politique publique saine, milieux favorables, action communautaire, aptitudes individuelles, réorientation des services – 3. Primaire – 4. Gordon (1983) – 5. Loi Climat et résilience (art. 265) ; 11 février 2026 – 6. 3 axes, 20 mesures – 7. 50 % de produits durables et de qualité dont 20 % de bio (et 60 % pour*

viandes et poissons) – 8. ANSES ; Santé publique France – 9. COS (10 ans), SRS (5 ans), PRAPS – 10. 9,60 / 12 = 0,80 €

– – 11. ETP, prévention tertiaire (BC1) – 12. Réalisé / prévu × 100.

9. Flashcards à découper

Recto : Charte d'Ottawa – date et 3 stratégies ?	Verso : 21 novembre 1986 ; plaider, conférer les moyens, servir de médiateur
Recto : Prévalence ou incidence : laquelle baisse avec la prévention primaire ?	Verso : L'incidence (nouveaux cas)
Recto : Universalisme proportionné : auteur, date, principe ?	Verso : Marmot, 2010 ; pour tous, avec une intensité proportionnelle au désavantage
Recto : PNNS en vigueur et son objectif enfant ?	Verso : PNNS 5 (2026-2030) ; − 30 % de surpoids et d'obésité chez les enfants et adolescents
Recto : Que signifie SMART ?	Verso : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel
Recto : Rôle de l'ARS en prévention ?	Verso : PRS, financement (FIR), appels à projets, CLS, déclaration des programmes d'ETP
Recto : Paradoxe de Rose ?	Verso : Beaucoup de personnes à faible risque produisent plus de cas que peu de personnes à haut risque
Recto : Les 3 formes d'éducation pour la santé du guide BTS ?	Verso : Nutritionnelle, alimentaire, sensorielle

Fiches-outils du chapitre 1

Ces 8 outils complètent les fiches F1 à F14 pour les notions propres au chapitre 1. Ils sont vierges, à imprimer ou à remplir dans Word, et servent en stage (période 1 surtout), en préparation du dossier E5 et en révision.

Outil	Intitulé	Utilité
O1.1	Qualifier mon action	Nommer précisément le mode d'intervention et le niveau de prévention (oral E5)
O1.2	Portrait express de mon territoire	Collecter les données de base du diagnostic (F1)
O1.3	Carte des acteurs de mon territoire	Identifier partenaires, financeurs, ressources
O1.4	Inscrire mon projet dans les politiques en vigueur	Rédiger la partie « contexte » du dossier
O1.5	Analyser un projet avec la Charte d'Ottawa	Vérifier que le projet ne se limite pas à l'information
O1.6	Les déterminants de l'alimentation de mon public	Appliquer le modèle de Dahlgren et Whitehead
O1.7	Tableau de veille des politiques nutritionnelles	Tenir à jour les versions des textes (C3.4)
O1.8	Check-list éthique et non-stigmatisation d'un message	Contrôler un support avant diffusion

O1.1 – Qualifier mon action

Intitulé de l'action

Public (qui, combien, caractéristiques)

Problème de santé visé

Question	☐	Justification
Mode : surveillance / veille sanitaire	☐	
Mode : promotion de la santé (agit sur déterminants, milieux, politiques, pouvoir d'agir)	☐	
Mode : prévention (problème défini)	☐	
Mode : éducation pour la santé – nutritionnelle	☐	
Mode : éducation pour la santé – alimentaire	☐	
Mode : éducation pour la santé – sensorielle	☐	
Attention : s'agit-il d'ETP (patients, programme déclaré à l'ARS) ? → BC1	☐	
OMS : primaire (incidence)	☐	
OMS : secondaire (dépistage, prévalence)	☐	
OMS : tertiaire (complications)	☐	
OMS : quaternaire (surmédicalisation)	☐	
Gordon : universelle	☐	
Gordon : sélective	☐	
Gordon : indiquée	☐	
Approche : informative / persuasive / participative	☐	
Universalisme proportionné appliqué ?	☐	

Ma phrase de qualification pour l'oral (4 phrases : mode, prévention, promotion, politiques)

O1.2 – Portrait express de mon territoire

> **Consigne**
> Pour chaque indicateur, notez la valeur pour votre territoire et une valeur de comparaison (département, région ou France), avec la source et l'année. Sources utiles : Insee (statistiques locales), Géodes (Santé publique France), ORS (Score-santé), ARS (diagnostic du PRS, CLS), *sig.ville.gouv.fr* (QPV), Drees.

Indicateur	Mon territoire	Comparaison	Source	Année
Population totale				
Part des moins de 20 ans / des 65 ans et plus				
Familles monoparentales (%)				
Taux de pauvreté (%)				
Taux de chômage (%)				
Quartier prioritaire (oui/non, nom)				
Espérance de vie / mortalité prématurée				
Surpoids, obésité (enfants, adultes)				

Indicateur	Mon territoire	Comparaison	Source	Année
Diabète traité, maladies cardiovasculaires (ALD)				
Offre alimentaire (commerces, marché, restauration rapide)				
Restauration scolaire (tarification, EGalim)				
Aide alimentaire (épicerie, banque alimentaire)				
Équipements sportifs, espaces verts				
Professionnels de santé (MSP, diététiciens, PMI)				

Trois constats principaux

O1.3 – Carte des acteurs de mon territoire

Niveau	Acteur (nom exact)	Rôle / missions	Intérêt pour mon projet (données, partenaire, financeur, relais)	Contact (fonction, mail professionnel)
National				
Régional (ARS, DRAAF, Promotion Santé, ORS)				
Départemental (PMI, action sociale)				
Commune / intercommunalité (CCAS, CLS, PAT, politique de la ville)				
Éducation (écoles, collèges, santé scolaire)				
Santé de proximité (MSP, CPTS, médecins)				
Social (centres sociaux, CAF)				
Associations (aide alimentaire, sport, culture, patients)				
Économiques (commerces, marché, producteurs, entreprises)				
Habitants / usagers (groupes, conseils citoyens)				

O1.4 – Inscrire mon projet dans les politiques en vigueur

> **Consigne**
>
> Vérifiez la **version en vigueur** de chaque texte le jour de la rédaction (fiche O1.7). Citez l'axe, l'action ou l'objectif précis, avec la date.

Texte / dispositif	Axe, action ou objectif auquel mon projet répond	Référence (date, lien)
Stratégie nationale de santé		
SNANC 2025-2030		
PNNS 5 (2026-2030)		

Texte / dispositif	Axe, action ou objectif auquel mon projet répond	Référence (date, lien)
PNA 4 (2026-2030)		
Lois (EGalim, Climat et résilience…)		
PRS de ma région (SRS, PRAPS)		
Contrat local de santé		
Projet alimentaire territorial		
Contrat de ville / QPV		
Projet de la structure d'accueil		

Rédaction du paragraphe « contexte » (5 à 8 lignes)

O1.5 – Analyser un projet avec la Charte d'Ottawa

1. Élaborer une politique publique saine

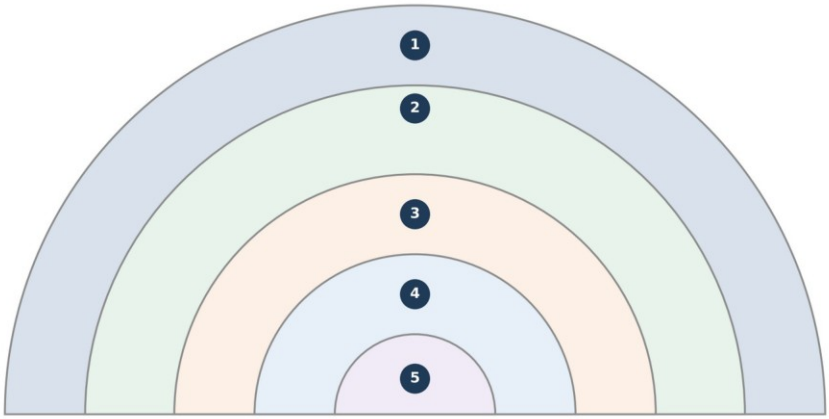
2. Créer des milieux favorables

3. Renforcer l'action communautaire

4. Acquérir des aptitudes individuelles

5. Réorienter les services de santé

O1.6 – Les déterminants de l'alimentation de mon public



Modèle de Dahlgren et Whitehead (1991) – à légender

Couche du modèle	Déterminants observés chez mon public	Levier d'action possible
1. Âge, sexe, hérédité		
2. Style de vie personnel		
3. Réseaux sociaux et communautaires		
4. Conditions de vie et de travail		

Couche du modèle	Déterminants observés chez mon public	Levier d'action possible
5. Conditions socio-économiques, culturelles, environnementales		

O1.7 – Tableau de veille des politiques nutritionnelles

Texte	Version vérifiée	Date de vérification	Statut (en vigueur, en révision, abrogé)	Source (lien) et changement repéré
SNANC	2025-2030 (11/02/2026)	05/10/2026	En vigueur	ecologie.gouv.fr
PNNS	PNNS 5 2026-2030 (08/04/2026)	05/10/2026	En vigueur	sante.gouv.fr ; mangerbouger.fr
PNA	PNA 4 2026-2030	05/10/2026	En vigueur	agriculture.gouv.fr
Repères alimentaires adultes	Santé publique France, 2019	05/10/2026	En vigueur, révision annoncée	mangerbouger.fr
Nutri-Score	Arrêté du 14/03/2025	05/10/2026	En vigueur (transition 2 ans)	sante.fr
EGalim, bilan « ma cantine »				
PRS de ma région				

O1.8 – Check-list éthique et non-stigmatisation d'un message ou d'un support

Critère	Oui / Non	Correction à apporter
Le message est positif et valorise ce que les personnes peuvent faire		
Il évite les mots culpabilisants (« mauvais aliments », « il faut », « interdit »)		
Il n'associe pas poids et valeur de la personne ; pas d'images dégradantes		
Il tient compte des contraintes (budget, temps, équipement)		
Il respecte les cultures et les pratiques religieuses		
Il est lisible (littératie : phrases courtes, pictogrammes, police ≥ 12 pt)		
Il est traduit ou accompagné oralement si nécessaire		
Les informations sont validées, datées et sourcées (repères officiels)		
Aucune marque n'est promue ; pas de conflit d'intérêts		
Les images de personnes ont une autorisation écrite (droit à l'image)		
Aucune donnée personnelle ou de santé n'apparaît		
Le support a été testé auprès de quelques personnes du public		